

“鱼”与“熊掌”可以兼得吗？医疗保险制度的不可能三角

电院 2504 班 李谨硕 525030910098

医疗保险制度在现实中是一个复杂的系统，涉及多方利益的协调与资金流动的平衡。尽管各国制度安排各异，但其基本参与者、运行逻辑与核心矛盾却高度相似。

简单来看，医保体系中有三个关键角色：需求方（患者）、供给方（医疗机构）和支付方（保险机构或政府）。需求方通过缴纳保费或税收预先出资，形成资金池；支付方在需要时向供给方支付医疗费用；供给方则提供医疗服务。医保的本质是一种风险共担机制：通过大数法则将个体的疾病风险分摊至整个参保群体，将少数人可能面临的灾难性医疗支出，转化为多数人可承受的小额定期支付。这一机制，可谓人类社会化进程中的一大智慧结晶。

然而，医疗保险制度面临一个经典的“不可能三角”：即很难同时完美实现控制成本、保持服务质量与确保医疗可达性三大目标。若强调质量与可达性，成本往往失控；若注重控制成本与广泛覆盖，服务质量可能下滑；而若只求质量与成本可控，则医疗资源的可达性将受限，甚至沦为少数人的特权。因此，各国医保体系实际上都是在三者之间做出符合国情的权衡。

美国在质量与成本之间挣扎，显著牺牲了可达性。其体系由商业保险、公共医保（如 Medicare 和 Medicaid）以及大量未参保人群构成，高度强调医疗质量与技术领先，患者选择权大、等待时间短。但代价是成本全球最高，约占 GDP 的 18%。保险费用昂贵导致数以百万计民众缺乏保障，“看病贵”成为严峻社会问题。美国模式可视为以“可达性”为代价，追求“质量”与“自由”。

英国则以国家卫生服务体系（NHS）为代表，突出可达性与成本控制。体系基于

税收筹资，原则是“按需分配而非按支付能力”，实现全民覆盖，看病基本免费。作为单一支付方，政府拥有强议价能力，有效控制总支出。但预算限制也带来问题：非紧急治疗常需长时间排队，技术更新与设备投入相对滞后。英国模式是以部分“质量”与“及时性”换取“公平”与“成本可控”。

德国作为医保制度的起源国，尝试走一条中间道路。它以法定医保为主、私人医保为辅，实现全民覆盖，服务质量高，等待时间短。但成本压力持续存在，政府需通过 DRG 付费、提高自付比例等方式不断调控。德国模式可视为在“可达性”与“质量”之间尽力维持平衡，而与“成本”进行长期博弈。

新加坡则构建了一套精密而独特的“3M 体系”，以个人医疗储蓄账户 (Medisave) 为基础，辅以大病保险 (MediShield Life) 与政府援助基金 (Medifund)。制度强调个人责任，通过共付机制和公立资源管控有效抑制过度需求，实现低支出下的良好健康成果。全民享有基本保障，但服务质量存在梯度，付费多则享受更优待遇。新加坡在控制成本的同时，兼顾了基础可达性与质量分层。

可见，并不存在完美的医疗保险制度。每一个体系都是特定社会在价值观、经济水平与政治共识之下做出的现实取舍。如何在成本、质量与公平之间找到可持续的平衡点，始终是医保改革的核心命题。